保健人材とシステム思考

みんなで考える「つながり」の医療

— システム思考って何だろう？ —

参考文献

2026-04-01 · AI（Claude）作成・主な出典は原典で確認

こんな経験、ありませんか？

ある日の病棟で…

- 看護師Aさん:「退院は明日って聞いてますけど、ケアマネさんまだ来てないですよね？」
- リハビリBさん:「え、退院延期になったんじゃ？」
- 医師Cさん:「家族への説明はMSWさんがやってくれるって…」
- MSW Dさん:「私、今日初めてこの患者さんの話聞いたんですけど…」

みんな一生懸命やっているのに、なぜかうまく回らない。

*それは「人」の問題ではなく、**「つながり方」の問題** かもしれません。*

今日のゴール

この10分が終わったら：

1. **ざっくり説明できる**：「システム思考」ってこういうこと、と同僚に伝えられる
2. **自分の仕事に1つ使える**：「つながり」を意識した行動を1つ始められる
3. **振り返れる**：うまくいった / いかなかったを「仕組み」の視点で見られる

「システム思考」をひとことで言うと

木を見て、森も見る

いつもの考え方	システム思考
「誰が悪い？」	「仕組みのどこが詰まっている？」
問題を1つずつ潰す	問題のつながりを見る
うまくいかない → もっと頑張る	うまくいかない → やり方を変える

WHOも言っています

WHO と NHS England のウェビナー（2026年1月）の開催案内は、医療の人材を、地域・教育・技術・財政・リーダーシップを含む**広いエコシステム** の中で捉えることを掲げています。

あなたも、このエコシステムの大事な一部です。

3つのキーワード

1. つながりの輪（フィードバックループ）

忙しい → ミスが増える → 確認作業が増える → もっと忙しい → …

- こういう「ぐるぐる」を見つけることが第一歩
- 悪い輪もあれば、良い輪もある（声かけ → 安心 → 余裕 → もっと声かけ）

2. 全体から生まれるもの（創発）

- 「いい人」を集めても「いいチーム」になるとは限らない
- チームの雰囲気・文化は、メンバーの**関わり方**から生まれる
- 1人の行動がチーム全体に波及する

3. 小さなツボ（レバレッジポイント）

- 全部を変えなくていい。**1箇所変えるだけ**で全体が動くポイントがある
- 例: 朝のカンファレンスで「今日退院の患者、準備OK？」と一言聞くだけで退院調整がスムーズに

やってみよう

グループ対話（3〜4人、3分）

お題: あなたの部署で「ぐるぐる回っている悪循環」を1つ見つけてください

例:

- ナースコール多い → 記録が後回し → 申し送りが雑に → 次の勤務者が困る → ナースコール対応が遅れる
- 薬の問い合わせが多い → 薬剤師が病棟に来られない → 疑義照会が溜まる → まとめて対応 → 待ち時間が長い

次に: その悪循環の中で「ここを1つ変えたら全体が良くなりそう」というポイントを見つけてください

まとめ

明日からできること ＋参考情報

職種別アクション

職種	明日からやってみること
看護師	申し送りで「この患者に関わっている人、全員伝わってる？」と確認
リハビリ	退院に向けたリハ計画を、看護師・MSWと一緒に立てる場を作る
薬剤師	処方変更時に「この変更が患者の生活にどう影響するか」を一言添える
事務	予約・書類の流れで「ここで情報が止まっている」箇所を1つ見つける
全員共通	「なぜうまくいかないか」を人ではなく仕組みで考えてみる

まとめ

明日からできること ＋ 参考情報（続き）

覚えておきたい 1つのこと

うまくいかないとき、「誰が悪い」ではなく「どこが詰まっている」と考える。

それだけで、チームの会話が変わります。

もっと知りたい方へ

- WHO — Embracing Complexity: Systems Thinking for Health Workforce Strengthening（2026年1月27日ウェビナーの開催案内）
- ドネラ・H・メドウズ 著『世界はシステムで動く』（枝廣淳子 訳、英治出版、2015年）— システム思考の入門書